3.2.1.1. 부록 1. 응급진료센터 중증도 분류

담당부서	응급의학과				
제정일	2006.09.	최종개정일	2023.01.	최종검토일	2025.03.

응급진료센터 중증도 분류
(Classification of Emergency Care Center Triage)

목적:

응급진료센터에 내원하는 긴급한 환자의 의학적 판단에 기초한 중증도를 평가하여 우선순위에 따른 선별적이고 신속한 진료가 이뤄지도록 하여 환자진료의 흐름을 원활하게 조절함으로써 환자, 보호자에게 적절한 응대, 교육 및 상담을 실시하여 긴급 정도에 따라 최적의 진료를 제공하고자 한다.

정의:

응급환자 중증도 분류(Triage)란 응급진료센터에 내원한 환자를 일차적이고 신속한 의학적 판단에 따라 중증도를 분류하는 것으로서 주요지표는 ABCD(Airway, Breathing, Circulation, Disability), 활력징후, 의식상태와 연령, 증상의 경중 및 급, 만성이 포함되며 한국형 응급환자 분류도구(Korean Triage and Acuity Scale; KTAS)에 의해 환자를 5군으로 나눈다.

절차:

1. 환자가 응급진료센터에 내원하면 중증도 분류 기준에 맞춰 중증도 분류 간호사가 환자 초기사정을 한 후 진찰실로 안내하며 응급의학과 진료 후 진료구역배정 및 대기 여부에 따른 결정이 되면 업무 흐름에 따라 환자를 안내한다.
2. KTAS 를 사용하여 환자의 초기 사정이 최대한 빨리 이뤄지도록 하며 환자를 분류하여 적절한 진료를 받을 수 있도록 설명하고 안내한다. <개정 2021.1>
   1) 1 단계 환자는 A 구역 접수와 동시에 즉시 진료를 볼 수 있도록 조정한다.
   2) BEST(Stroke), FIRST(Myocardial Infarction), SEPSIS(Septic Shock), SPEED(Post Partum Bleeding), AAAAT(Acute Asthma Attack Assessment & Treatment), TRAUMA 등 Critical Pathway 환자는 1 단계 환자에 준해서 A 구역 접수와 동시에 A 구역 응급의학과 상급 전공의나 전문의의 진료를 진행한다.
   3) 2 단계 환자가 내원하는 경우 간호사정은 즉시 시행하며 10 분 안에 진료를 볼 수 있도록 한다.
   4) 3 단계 환자는 30 분마다 환자를 재사정하며 진료를 볼 수 있게 한다.
   5) 4 단계 환자는 1 시간마다 환자를 재사정하며 진료를 볼 수 있게 한다.
   6) 5 단계 환자는 2 시간마다 환자를 재사정하며 중증도 분류 후 정해진 알고리즘과 시간에 따라 진료를 볼 수 있게 하고 환자를 재사정하고 재분류를 한다.

3. 5 명 이상의 응급진료센터 진료 대기환자 발생 시 중증도 분류 및 진료 지침

1) 중증도 분류 대기환자 ≧ 5 명

(1) 진찰실 응급의학과 의료진은 가능한 신속하게 진료를 시행하며, Triage 간호사 또는 구조사가 대기실로 가서 환자의 신속 평가를 시행하여 우선순위를 정한다. <개정 2021.1>

(2) A 구역 상급 전공의는 응급의학과 전문의에게 다수의 대기환자 발생을 보고하며, 대기환자의 중증도 분류를 시행한 후 1 단계, 2 단계 환자는 즉시 A 구역에서 진료가 이루어질 수 있도록 한다.

(3) 응급의학과 전문의는 대기환자들의 중증도 분류와 진료가 신속히 이루어 질 수 있도록 응급진료센터의 인원과 자원의 배분을 조절하고 환자의 흐름을 감독한다.

2) 응급진료센터 진찰실 대기환자 ≧ 5 명

(1) 진찰실 응급의학과 의료진은 가능한 신속하게 진료를 시행하며, 당일 책임 전문의 또는 상급전공의 결정에 따라 추가 진찰실을 운영할 것을 판단한다. <개정 2021.1>

(2) A 구역 상급 전공의는 응급의학과 전문의에게 다수의 대기환자 발생을 보고하며, 대기환자의 진료와 거취결정을 시행한다.

(3) 응급의학과 전문의는 대기환자들의 진료와 거취결정이 신속히 이루어 질 수 있도록 응급진료센터의 인원과 자원의 배분을 조절하고 환자의 흐름을 감독한다.